| 7.1 감염예방·관리체계 구축 및 운영 | | | |
|---|---|---|---|
| 규 정 번 호 | 7.1 | 제 정 일 | 3주기 규정집 제정 |
| 관 련 인증기준 | 7.1 감염예방·관리체계 구축 및 운영 | 최근 개정일 | 2025-10-15 |
| 담 당 부 서 | 감염관리실 | 시 행 일 | 2025-11-01 |
| 검 토 책 임 자 | 병원운영위원회 | 검 토 주 기 | 2년 |
| 승 인 책 임 자 | 병원장 | 검토 예정일 | 2027-10-15 |
| 관 련 근 거 | 1. 의료법 시행규칙 제 43조, 제44조, 제46조<br>2. 의료관련 감염 표준예방지침 | | |

**▣ 목적 (Purpose)**

감염발생 위험을 감소시키기 위하여 감염예방 및 관리를 위해 기획, 통합, 조정, 지원하기 위한 체계를 운영함으로써 지속적인 조직문화의 변화를 지향하여야 한다.

**▣ 정책 (Policy)**

1. 감염예방 및 관리에 대한 규정이 있다.
2. 감염예방 및 관리를 위한 위원회를 운영한다.
3. 감염예방 및 관리활동을 수행하는 부서 및 적격한 자가 있다.

**▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)**

**1. 감염예방 및 관리를 위한 위원회 활동**

**가. 감염관리 위원회의 구성 및 임기**

1) 위원장 1명을 포함하여 7명 ~ 15명으로 구성한다.
2) 위원장은 본원의 병원장이며, 부위원장은 위원중에서 위원장이 지명한다.
3) 위원은 다음 각호에 어느 하나에 해당하는 사람과 병원장이 위촉하는 외부 전문가로 한다.
   가) 감염관리실장
   나) 진료부서의 장
   다) 간호부서의 장
   라) 감염 관련 의사 및 병원장이 필요하다고 인정하는 사람
4) 위원회의 사무를 처리하기 위하여 감염관리 담당자가 위원회의 간사가 된다.
5) 위원의 임기는 부서의 재직기간으로 하며 위촉 위원은 2년으로 하며 연임할 수 있다.

**나. 위원회의 역할**

1) 감염관리 위원회는 의료기관의 감염관리 활동의 기획, 통합, 조정, 지원을 하며 다음 사항을 심의 의결한다.
   가) 의료관련감염에 대한 대책, 연간 감염예방계획의 수립 및 시행에 관한 사항
   나) 감염관리요원의 선정 및 배치에 관한 사항
   다) 감염병환자등의 처리에 관한 사항
   라) 병원의 전반적인 위생관리에 관한 사항

마) 병원감염관리에 관한 자체 규정의 제정 및 개정에 관한 사항

바) 그 밖에 의료 관련 감염관리에 관한 중요한 사항

**다. 위원회의 운영**

1) 정기적 위원회 운영 : 위원회는 연 4회 이상 정기적으로 개최함을 원칙으로 한다.
2) 비정기적 위원회 운영 : 위원장 및 위원 과반수이상이 필요하다고 인정할 때 수시로 소집할 수 있다.
3) 회의는 재적인원 3분의 2 이상 참석으로 성립하며(업무출장, 환자진료 등 특별한 사유로 위임장 제출 시 출석으로 갈음 함) 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 위임장 제출을 포함하여 회의 성원 요건이 되었다 하더라도 실제 참석 정족수는 재적위원 과반수이상이 되어야 하며, 의결 시 가부동수인 경우에는 위원장이 결정한다.
4) 위원장은 위원회를 대표하며 업무를 총괄한다.
5) 위원회는 회의록을 작성하여 참석자의 확인을 받은 후 비치한다.
6) 그 밖에 위원회의 운영에 필요한 사항은 위원장이 정한다.

**라. 위원회 운영 결과 경영진 보고**

1) 위원회 회의를 운영 후 그 결과는 위원회 회의록을 작성하여 병원장에게 보고한다.

**2. 감염예방 및 관리활동 수행 부서 및 인력**

**가. 감염관리실(부서)의 역할**

1) 병원감염의 발생 감시
2) 병원감염관리 실적의 분석 및 평가
3) 직원의 감염관리교육 및 감염과 관련된 직원의 건강관리에 관한 사항
4) 그 밖에 감염관리에 필요한 사항

**나. 감염관리실 업무를 수행하는 사람의 인력 배치 및 자격 기준**

1) 실무 수행에 적합한 경력 및 자격

가) 감염관리실에서 감염관리 업무를 수행하는 사람은 감염관리에 관한 경험 및 지식이 있는 사람으로서 의료기관 경력 1년 이상으로 하며 의료법 시행규칙 별표 8의 2에 따라 의사, 간호사, 병원장이 인정하는 사람으로 각 1명씩 배치한다.

2) 감염예방 및 관리활동을 위한 교육 및 훈련

가) 감염관리실에서 업무를 수행하는 사람은 의료법 시행규칙 별표 8의 3에 따라 감염관리 교육을 매년 16시간 이상 이수한다.

나) 감염예방 및 관리활동을 위한 훈련이란 국내외 학회, 감염관리 연수과정, 정보와 데이터의 관리, 분석, 활용을 위한 훈련 등이 있다.

**3. 의료기관 전체 차원의 감염예방 및 관리 활동을 위한 연간계획 수립**

**가. 우선순위 선정 기준**

의료관련 감염 감시와 감염관리위험사정을 통해 우선순위를 선정한다.

**나. 우선순위에 따른 감염예방 및 관리활동의 선정**

우선순위에 따라 선정된 감염예방활동의 계획과 목표를 설정하여 아래와 같이 관리활동 을 실시한다.

**다. 활동내용**

1) 감염 감시 활동 : 손위생 수행 모니터링 등

2) 교육계획 : 연간 감염관리 교육에 관한 사항
3) 감염예방 및 관리 활동을 위한 의료기관의 지원
가) 손위생 포스터 제작, 캠페인 등

**라. 성과 평가 계획**

1) 의료기관 전체 차원의 감염예방 및 관리 활동계획 수립 시 성과를 평가하여 차기년도 연간계획 수립 시 반영한다.

**마. 감염예방 및 관리 위원회의 검토 · 승인, 경영진 보고**

1) 감염예방 및 관리 활동을 위한 연간 계획 수립 및 활동에 대해서는 감염관리위원회에서 검토 및 승인하고 경영진 및 병원장에게 보고한다.

**4. 감염예방 및 관리 활동 계획에 따라 경영진은 필요한 자원을 지원한다.**

**가. 인적, 기술적 지원 : 감염관리 실무에 적합한 전문교육 및 훈련을 지원한다.**

1) QPS활동 도구, 모니터링 도구 개발
2) 정보와 데이터 관리, 분석, 활용을 위한 훈련
3) 컴퓨터(microsoft office) 활용 능력 향상을 위한 훈련
4) 지표 및 통계교육을 통해 데이터 관리 훈련 등

**나. 행정적 지원**

1) 감염예방 및 관리활동을 위한 손위생 포스터 제작 지원
2) 감염예방을 위한 캠페인을 시행할 수 있다.
3) 회의비, 교육비, 활동비 등을 지원한다.

## ▣ 부록 (Appendix)

1. 감염관리 위원회 조직도
2. 감염관리 위원회 운영 지침
3. 감염관리 위원회 회의록
4. 연간 감염관리 활동 계획서
5. 감염관리 우선순위 사정도구

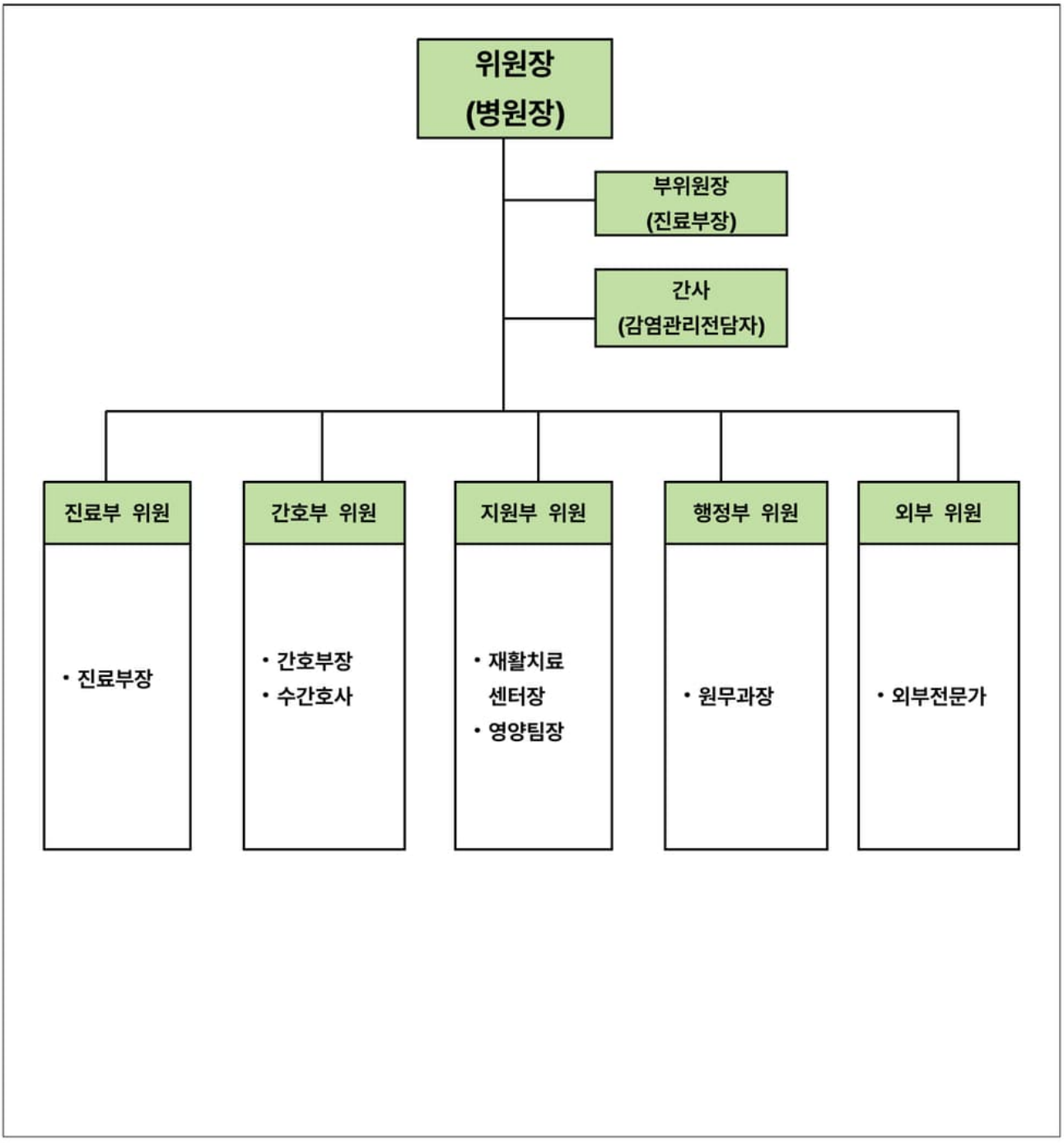
▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

| 승 인 책 임 자 | 병 원 장 | 이름 | | 서명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 승 인 일 | . . . | | | | |

부록1. 감염관리 위원회 조직도

# 감염관리위원회 조직도



부록2. 감염관리 위원회 운영 내규

# 감염관리 위원회 운영 내규

**제1조 (목적)**

1. 본 내규는 네이처요양병원(이하 '병원'이라 한다)의 병원감염의 예방대책을 심의하고 염관리에 필요한 기준을 확립하여 병원에서 발생할 수 있는 감염을 예방하며, 이를 통해 병원을 출입하는 환자에 대한 진료수준의 향상 및 직원, 일반인의 보건증진에 기여함을 목적으로 한다.

**제2조 (적용범위)**

1. 병원의 감염관리 위원회의 구성 및 운영에 관하여 타 규정에 별도로 정한 것을 제외하고는 본 내규에서 정하는 바에 의한다.

**제3조 (위원회의 구성)**

1. 위원회의 위원장은 병원장이 되며, 간사 및 위원은 다음 각호와 같다.
   가. 간사 : 감염관리전담자
   나. 위원 : 병원장, 진료부장, 간호부장, 3병동 수간호사, 재활치료센터장, 영양팀장, 원무과장, 외부위원

**제4조 (위원회의 기능)**

1. 위원회는 병원 내의 효율적인 감염관리를 위하여 다음 각호의 내용을 관장 및 결정한다.
   가. 의료 관련 감염에 대한 대책에 관한 사항
   나. 연간 감염관리 계획의 수립 및 시행, 평가에 관한 사항
   다. 감염병 환자, 감염병 의사환자 또는 병원체 보유자의 처리에 관한 사항
   라. 의료 관련 감염의 전반적인 위생관리에 관한 사항
   마. 의료 관련 감염관리에 관한 자체 규정의 제정 및 개정에 관한 사항
   바. 감염예방 및 관리 활동 수행을 위한 적격한 자 배치에 관한 사항
   사. 그 밖에 의료 관련 감염관리에 관한 중요한 사항

**제5조 (위원회의 임무)**

1. 위원장은 위원회를 대표하고 회의를 총괄한다.
2. 간사는 감염관리 회의 자료의 수집과 관리, 회의록 작성, 관련 부서와의 연락 등 업무를 담당한다.
3. 위원회는 병원감염의 양상을 파악하여 감염원이 될 수 있는 모든 시설과 치료, 처치 등에 대하여 수시로 개선대책을 강구하여 병원장에게 건의하고 이를 시정 조치할 수 있도록 하여야 한다.
4. 위원회에서 결정된 사항은 병원장의 승인을 득하여 관련부서 및 전 부서에 통보하여야 한다.

**제6조 (위원회 회의)**

1. 위원회는 정기회의와 임시 회의로 운영된다.
2. 정기회의는 분기별 1회 개최하며, 임시 회의는 위원장이 필요하다고 판단되었을 때 개최할 수 있다.

3. 위원회는 재적위원 3분의 2 이상이 소집 요구가 있을 시 개최할 수 있으며, 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 가결한다. 가부 동수일 때는 위원장이 결정한다.

**제7조 (감염관리 담당자의 지정)**

1. 위원장은 지정된 구역 내의 감염관리 업무를 담당하도록 하기 위해 각 부서별로 필요한 수의 인원을 감염관리 담당자로 지정할 수 있으며 별도의 지정이 없는 경우 각 부서별 책임자를 감염관리 담당자로 정한다.

**제8조 (병원감염의 보고)**

1. 병원감염 발생 시 실무담당 부서별 감염담당자는 계속 파급될 가능성이 현저히 높을 경우 지체없이 이를 위원회에 보고한다.
2. 그 외의 경우는 각 부서별 감염담당자는 감염관리위원회 간사에게 보고하고 간사는 이를 취합하여 위원회에 보고한다.
3. 위원회에서 결정된 사항은 병원장의 승인을 득하여 공표한다.

**제9조 (기타)**

1. 이 내규에 명시되지 않은 감염관리에 관한 사항은 본 위원회의 심의를 거쳐 병원장의 승인을 득한 후 시행한다.

부록3. 감염관리 위원회 회의록

# 감염관리위원회 회의록(1차)

일시 : 202 년 월 일

| 참석현황 | 참석대상자 | |
|---|---|---|
| | 참석자 | |
| | 불참자 | |

| 직책 | 소속 | 성명 | 서명 |
|---|---|---|---|
| 위원장 | 병원장 | | (서명) |
| 부위원장 | 진료부장 | | (서명) |
| 간사 | 감염관리실 | | (서명) |
| 위원 | 간호부장 | | (서명) |
| 위원 | 원무과장 | | (서명) |
| 위원 | 재활치료센터장 | | (서명) |
| 위원 | 수간호사 | | (서명) |
| 위원 | 영양팀장 | | (서명) |
| | | | (서명) |
| | | | (서명) |

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

# 감염관리위원회 회의록

| 결재 | 감염관리담당자 | 감염관리위원장 |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 회의구분 | ■ 정기회의 □ 임시회의 | | |
| 일 시 | | 장 소 | 1층 회의실 |
| 안 건 | | | |
| 주요논의 및 결정사항 | | | |
| 미결사항 | | | |
| 첨부자료 | | | |

부록4. 연간 감염관리 활동 계획서

# 연간 감염관리 활동 계획서

| 내 용 | | 담당자 | 2026년 | | | | | | | | | | | | 예산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 감염관리 사업 | 위원회 개최 (반기별 1회) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 감염관리 활동 사업 연간계획서 작성 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 환자집단 유행발생 시 감시 및 발생 조사/개선활동 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 손위생 수행률 모니터링 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 손위생 증진활동 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 감염관리 교육 | 전 직원 교육 및 캠페인 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 필요부서 교육(유행발생시, 부서요청시) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 감염관리담당자 외부교육 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 직원 감염 관리 | 인플루엔자 예방접종 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B형간염 예방접종 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 잠복결핵검사 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 직원감염노출관리 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 법정감염병 | 법정감염병 신고(법정 감염병 개정 시 업무 반영) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 환경관리 | 소독실, CI / BI 확인 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 환경 및 청소 관리 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총 예산 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 부록5. 감염관리 우선순위 사정도구

감염관리위험사정(riskassessment)

| 번호 | 위험 항목 | 근거 | 위험정도 | | | 위험점수 (PxSxP) | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 발생, 노출가능성 (Probability) | 심각성 (Severity) | 준비, 대처가능 (Preparedness & Response) | | |
| | | | 1-거의 없음<br>2-가끔있음<br>3-때때로있음<br>4-자주있음<br>5-지속적임 | 1- 미약 insignificant<br>2-약함minor<br>3-보통moderate<br>4-심각major<br>5-극심함extreme | 1- 준비됨 또는 불가능<br>2-일부준비,보완불가<br>3-일부준비,지원가능<br>4-준비안됨,지원가능 | | 1-24 낮은 위험<br>25-49 중간위험<br>50-74 높은위험<br>75-100매우위험 |
| 환자에 영향을 주는 감염위험요인 | | | | | | | |
| A | 손위생 관련 감염 위험 요인 | | | | | | |
| A-1 | 손위생 수행률 | 2025년 90%이하 | 3 | 3 | 3 | 27 | 중간위험 |
| B | 삽입기구 관련 감염 위험 요인 | | | | | | |
| B-1 | 유치도뇨관관련 요로감염 | 2025년 KONIS 참여기관 아님 미조사 | 2 | 3 | 3 | 18 | 낮은위험 |
| C | 시술/수술 관련 감염 위험요인 | | | | | | |
| C-1 | 처치 / 시술부위 감염 | 2025년 KONIS 참여기관 아님 미조사 | 1 | 3 | 1 | 3 | 낮은위험 |
| D | 다재내성균 관련 감염 위험요인 | | | | | | |
| D-1 | MRSA | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| D-2 | MRAB | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| D-3 | MRPA | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| D-4 | VRE | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-5 | CRE | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| E | 감염병 관련 감염 위험 요인 | | | | | | |
| E-1 | 법정감염병 | CRE(2025년 보유환자 입원 0명, 신규발생 3명) VRE(2025년보유환자입원 0명,신규발생2명) | 2 | 3 | 3 | 18 | 중간위험 |
| E-2 | 격리실 구비 및 사용 지침 준수 | 1인실 사용 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| E-3 | 인플루엔자 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 낮은위험 |
| E-4 | 옴 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 낮간위험 |
| E-5 | 결핵 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| E-6 | 지역유행감염병 | 인플루엔자 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| F | 의료 물품관련 감염 위험요인 | | | | | | |
| F-1 | 재사용 기구의 부적절한 세척 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 낮은위험 |
| F-2 | 부적절한 소독제 선택 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 낮은위험 |
| F-3 | 소독제 희석농도, 침적시간 미준수 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 낮은위험 |
| F-4 | 부적절한 고수준소독 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 낮은위험 |
| F-5 | 부적절한 멸균 과정 | N | 1 | 2 | 3 | 6 | 낮은위험 |
| F-6 | 멸균기의 부적절한 관리 | N | 1 | 2 | 3 | 6 | 낮은위험 |
| F-7 | 세척, 소독, 멸균물품의 부적절한 운반 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 낮은위험 |
| F-8 | 소독/멸균물품의 부적절한 보관 | N | 1 | 2 | 3 | 6 | 낮은위험 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 환경관련 감염 위험요인 | | | | | | |
| G-1 | 청결, 오염구역 혼재 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 낮은위험 |
| G-2 | 환경표면의 정기적, 적절한 청소 및 소독 | Y | 1 | 2 | 3 | 6 | 낮은위험 |
| G-3 | 건축이나 리모델링관련 감염위험 | N | 1 | 2 | 3 | 6 | 낮은위험 |
| H | 지역사회 감염위험요인 | | | | | | |
| H-1 | 지리적 특성관련(예; 휴전선, 바다인접, 홍수, 태풍 등) 감염위험요인 | 없음 | 1 | 2 | 3 | 6 | 낮은위험 |
| H-2 | 지역사회 인구분포관련(외국인, 노인 등) 감염위험요인 | 없음 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| 직원에게 영향을 주는 감염위험요인 | | | | | | | |
| I | 감염질환 노출 | | | | | | |
| I-1 | 혈액매개질환노출(주사침 손상 등) | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | 낮은위험 |
| I-2 | 수두노출 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 낮은위험 |
| I-3 | 결핵노출 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| I-4 | 음노출 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 낮은위험 |
| J | 소독제 등 화학물질 노출 | | | | | | |
| J-1 | 피부나 점막 노출 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 낮은위험 |